

Dyspnée

Anamnèse

1. Caractériser la dyspnée
 - a. Qualité
 - b. Depuis quand ?
 - c. Condition de survenue
 - d. Permanente / intermittente
 - e. **Nocturne / diurne** (dyspnée paroxystique nocturne = IC)
 - f. Aggravation / diminution
 - g. Facteurs favorisants
 - i. Position
 - ii. Froid
 - iii. Poussière, pollen, animaux
 - iv. Effort
 - h. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
2. Symptômes associés
 - a. Doul. thoraciques (caractériser si +)(oppressives → card, respiro-dép → pulm)
 - b. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration : couleur – sang
 - c. Hémoptysie
 - d. Œdèmes MI – douleur MI
 - e. Orthopnée – dyspnée paroxystique nocturne
 - f. Nycturie
 - g. **Palpitation**
 - h. Fièvre
 - i. ORL : dysphonie – obstruction nasale
3. Symptômes B
 - a. Sudations nocturnes
 - b. Perte de poids
4. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments (hormonothérapie)
 - e. Allergies
5. ATCD familiaux
6. **Voyage – immobilisation**
7. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue
 - d. Diète
 - e. Activité physique

Signes d'alarmes :

- Diminution de l'état de conscience, agitation, confusion
- Difficultés à parler (mots isolés)
- Détresse respiratoire : utilisation des muscles accessoires, tirage intercostal
- FR < 8/min ou > 25/min
- Saturation < 90%
- Cyanose
- Diaphorèse
- Arythmie nouvelle
- Fréquence cardiaque > 120/min
- TA < 90/60 mmHg (nouvelle)
- PF < 50% du prédict ou < 200 L/min

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. **Oedèmes des MI (godet)**
 - f. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspidé
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Antérieure
 - ii. Postérieure : 4 plages en comparant
 - iii. Latérales : 2 plages

Bruits respiratoires : (<https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1302901>)

- Râles crépitants fins : fibrose pulmonaire, pneumonie, stase cardiaque
- Râles crépitants grossiers : sécrétions bronchiques (bronchiectasie, bronchite)
- Ronchi : asthme, BPCO
- Sibilances : asthme, BPCO, insuffisance cardiaque
- Stridor : sténose des voies respiratoires centrales

DD

- **Aigu (< 3 semaines)**
 - *Origine cardiaque*
 - *Cardiopathie ischémique aiguë*
 - *Décompensation insuff. cardiaque (ischémique, valvulaire, rythmique)*
 - *Tamponnade*
 - *Origine respiratoire*
 - *Asthme*
 - *BPCO décompensé*
 - *EP*
 - *Pneumothorax*
 - *Pneumonie*
 - *Obstruction VA (corps étranger, anaphylaxie)*
 - *Autres*
 - *Toxiques*
 - *Métaboliques*
 - *Psychogène*
- **Chronique**
 - *Origine cardiaque*
 - *Insuffisance cardiaque (ischémique, valvulaire, rythmique)*
 - *Origine respiratoire*
 - *BPCO*
 - *Asthme*
 - *Maladie interstitielle (fibrose)*
 - *Hypertension pulmonaire (dû à cirrhose, ou post EP, ...)*
 - *Patho. extra-pulmonaire (squel, obésité, mal. pleurale, neuro-musc)*
 - *Cancer*
 - *Origine métabolique / neurologique*
 - *Acidose métabolique*
 - *Insuffisance rénale*
 - *Acidose d'origine médicamenteuse*
 - *Diabète décompensé*
 - *Myopathies*
 - *Déconditionnement*

	Mouvements thoraciques	Fremitus	percussion	auscultation	Forme thoracique	particularités
Pneumothorax	diminués du côté atteint	diminué	tympanique	hypoventilation localisée	normale	
Syndrome obstructif	diminués des 2 côtés	diminué	normale ou tympanique	hypoventilation diffuse sibilances	thorax en tonneau	respiration lèvres pincées
Origine cardiaque	normaux	normal ou augmenté	normale ou matité	sibilances, râles crépitants, hypoventilation diffuse	normal	turgescence jugulaire, souffle cardiaque, OMI symétriques
Pneumonie	normaux ou diminués du côté atteint	augmenté	matité	souffle tubaire, râles crépitants	normal	
Epanchement pleural	diminués du côté atteint	diminué	matité	hypoventilation localisée	normal	
Obstruction des VAS	augmentés	normal	normale	stridor	normal	tirage inspiratoire

Examen complémentaire possibles :

- Rx thorax
- ECG
- Gazométrie si dyspnée aiguë
- Laboratoire
 - FSC
 - Fonction rénale
 - D-dimères
 - BNP / pro-BNP
 - Troponine
- Fonction pulmonaire
- Échocardiographie / ergométrie +/- spirométrie
- Imagerie : CT-scan, scintigraphie pulmonaire

Des taux normaux permettent d'exclure la maladie/l'origine de la dyspnée

Critères d'hospitalisation

- Asthme :
 - Patient à haut risque selon les ATCD
 - Entourage ne garantissant pas une réaction adéquate en cas d'évolution défavorable
 - Absence d'amélioration après un traitement initial
- BPCO
 - Fatigue respiratoire
 - EF > 38
 - Suspicion de foyer pulmonaire
 - OMI
 - Entourage défavorable
- Insuffisance cardiaque
 - Douleurs thoraciques
 - Comorbidités importantes
 - Souffle cardiaque nouveau
 - Entourage défavorable
- Pneumonie
 - Fièvre > 40 ou T < 35
 - Comorbidité sévère
 - Plusieurs lobes atteints
 - Épanchement pleural significatif
 - PaO₂ < 60mmHg
 - pH artériel < 7.35
 - Ht < 30%
 - Na < 130 mmol/L
 - Glycémie > 14 mmol/L

DD hyperventilation – asthme :
- En faveur d'un asthme

- Sibilances
- Sécrétions
- Toux